



Vårdprogram stroke

Medicinsk del
Rehabiliterande del

Slutenvård
Blekingesjukhuset

2020-01-01 – 2020-12-31

Förord

Vårdprogrammet för Stroke/TIA gäller för vård på Blekingesjukhuset och är tänkt att vara ett praktiskt stöd för alla medarbetare vilka har kontakt med patienten från inskrivning till utskrivning. Strävan är att formatet ska vara kortfattat och enkelt för att det ska vara ett användarvänligt redskap i vardagen. De som vill fördjupa sig mer i bakgrund, evidens m.m. hänvisas till andra källor exempelvis Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för Strokesjukvård och Stroke-up-date.

Vårdprogrammet kommer att revideras och uppdateras årligen under december månad och gäller därefter ett år i taget.

Utarbetad av:

Medicinsk del:

Håkan Johansson, Sektionsansvarig överläkare Neurologisektionen Medicinkliniken
Björn Servin, Överläkare Neurologisektionen Medicinkliniken
Martyna Rosol, Specialistläkare Neurologisektionen Medicinkliniken
~~Evelina Kask-Ogenblad, Specialistläkare Neurologisektionen Medicinkliniken~~
Anders Behrens, ST-läkare Neurologisektionen Medicinkliniken
Mayya Malmström Överläkare Neurologisektionen Medicinkliniken
Katarina Widebrant, Avdelningschef Strokeenheten Karlskrona
Ann-Charlotte Norén Carlsson, Sjuksköterska Strokeenheten Karlskrona
Elias Andersson, Sjuksköterska Strokeenheten Karlshamn
~~Emelie Bujukliev, Sjuksköterska Strokeenheten Karlshamn~~

Rehabiliterande del:

Athina Bampasi, Specialistläkare Rehabiliteringskliniken
Jessica Klintö, Arbetsterapeut Rehabiliteringskliniken
~~Angelica Persson, Dietist Dietistmottagningen ->mail Ann-Sofie Holgersson 22/10- vem ist??~~
Ingrid Romberg, Kurator Rehabiliteringskliniken
Franziska Hanewinkel, Logoped Rehabiliteringskliniken
Carina Abrahamsson, Sjukgymnast Rehabiliteringskliniken

Innehåll

Förord	3
Innehåll	4
A.	7
1.	Akut handläggning
	7
1.1	Patienter med misstänkt stroke och TIA
	7
1.1.1	Datortomografi (DT) hjärna
	7
1.1.2	Datortomografi hjärna med kontrast (DT angio)
	7
1.1.3	Laboratorieprover
	7
1.1.4	Övriga undersökningar
	7
1.2	Cerebral blödning
	7
1.2.1	Subarachnoidalblödning
	7
1.2.2	Intracerebral blödning
	8
1.2.3	Akut handläggning av cerebral blödning
	8
1.3	Ischemisk stroke/TIA
	9
1.3.2	Vid förmaksflimmer eller annan kardiell embolikälla
	9
1.4	Behandling av expansiv hjärninfarkt
	9
1.5	Högt blodtryck
	9
2.	Generellt omhändertagande av samtliga strokepatienter i akutskedet (dvs. de första 3 dyggen)
	10
2.1	Cirkulation i övrigt och elektrolytrubbningar
	10
2.1.1	Förhöjt blodsocker
	10
2.1.2	Feber
	10
2.1.3	Hypoxi
	10
2.2	Trombosprofylax på helt immobiliserade patienter
	10
2.3	Krampanfall
	10
2.4	Övervakning
	10
2.5	Omhändertagande av patient med sväljningssvårigheter
	11
3.	Fortsatt utredning med fokus på bakomliggande orsak till hjärninfarkt/TIA och hjärnblödning samt sekundärprofylax
	12
3.1	Undersökningar/provtagningar
	12
3.1.1	Carotisundersökning
	12
3.1.2	Diagnostik av förmaksflimmer
	12
3.1.3	Ekokardiografi
	12
3.1.4	Magnetresonanstomografi (MRT)
	12
3.2	Utvidgad utredning hos yngre patienter med stroke (18-55 år)
	13
	4

3.2.1 Ovanliga diagnoser	13
3.3 Cerebral blödning	13
3.4 Differentialdiagnoser	13
3.4.1 Neurologiska sjukdomar	13
3.4.2 Icke neurologiska sjukdomar	13
3.5 Sekundärprofylax	14
3.6 Behandling vid vissa specifika tillstånd	14
3.6.1 Kärldissektion	14
3.6.2 Sinustrombos	14
3.6.3 Vid hjärninfarkt och tidigare genomgången hjärnblödning	14
3.6.4 Vid hjärninfarkt/TIA orsakad av storkärlssjukdom med hög risk för återinsjuknande	14
4. Uppföljning/Utskrivning	15
B.	16
1. Inneliggande Rehabilitering	17
1.1 Förutsättningar för inneliggande rehabilitering	17
1.2. Kontraindicerade faktorer för inneliggande rehabilitering	18
2. Arbetsterapeut	19
2.1 Bedömning	19
2.2 Insatser	19
3. Sjukgymnast	21
3.1 Bedömning	21
3.2 Insatser	21
4. Logoped	23
4.1 Bedömning	23
4.2 Behandling	23
5. Dietist	24
5.1 Bedömning	24
5.2 Insatser	24
6. Kurator	25
6.1 Socialt arbete och psykosocialt behandlingsarbete	25
6.2. Utredning och bedömning av vårdbehov utifrån ett psykosocialt perspektiv	25
7. Sexolog	26
Appendix I	27
Utdrag ur Riksstrokes diagnoslathund	27
Appendix II Strokekontroller	29

A. Medicinsk del

1. Akut handläggning

1.1 Patienter med misstänkt stroke och TIA

- Plötsligt insättande fokala neurologiska bortfall.
- Om insjuknande inom 24 timmar. Se Rädda hjärnan – PM.

1.1.1 Datortomografi (DT) hjärna

- Akut (oberoende av tid på dygnet)
- TIA med endast amaurosis fugax är dock **inte** indikation för akut DT hjärna.

1.1.2 Datortomografi hjärna med kontrast (DT angio)

- **I normalfallet. Patienter med njursvikt, multisjuklighet och allvarliga sjukdomar i övrigt kan undantas.**

OBS! Strokepatienter skall med högsta prioritet inläggas på strokeenhet!

1.1.3 Laboratorieprover

- Rädda hjärnanpatient: Se Rädda hjärnan-PM.
- Övriga stroke/TIA patienter: Inkomstprover vid misstänkt stroke/TIA; PK, APTT, blodsocker, blodstatus, CRP, elstatus, Hba1c, kreatinin, blodfetter inklusive LDL, leverstatus.

Komplettera vid behov de blodprover som inte är tagna på akutmottagningen.

1.1.4 Övriga undersökningar

- EKG (på akuten/avdelningen)
- För TIA-patienter med bortfall från carotisterritoriet skriv remiss för ultraljud halskärl direkt om patienten är operabel, **om ej DT angio har uteslutit stenosis**. Se sekundärprofylax.

1.2 Cerebral blödning

1.2.1 Subarachnoidalblödning

- Åskknallshuvudvärk
- Syncope eller medvetandepåverkan möjligt debutsymtom.
- DT hjärna inom 6 timmar från debut säkert diagnostiskt enligt Socialstyrelsen (SoS). OBS! Säker debuttid. Patienten får inte ha andra neurologiska symtom än huvudvärk, normalt nervstatus (inkl. ögonbottenundersökning). Granskning utförs av läkare med neuroradiologisk kompetens.
- Om inte ovanstående föreligger och DT hjärna är utan anmärkning utförs LP med spektrofotometri tidigast 12 timmar efter debut.
- Vid positivt fynd direkt kontakt med Neurokirurgen (NK) i Lund.

1.2.2 Intracerebral blödning

- Hematom ökar i storlek under det första dygnet i en stor andel av fallen.
- Handläggningen baseras på individuell bedömning av prognos. Vakna patienter med små supratentoriella intracerebrala blödningar (<20-30 ml) har god prognos. Patienter med blödningar >110 ml, medellinjeöverskjutning >10 mm, hög ålder och/eller djup medvetslöshet har dålig prognos oavsett åtgärd.

1.2.3 Akut handläggning av cerebral blödning

- a) Reversering av antikoagulantia
- b) Blodtrycksbehandling
- c) Kan operation vara aktuell?

a) Antikoagulantibehandlad patient

OBS! Vid behov konsultera koagulationsjouren i Malmö!

- Warfarinbehandling (konsultera koagulationsjouren akut!)
 - Koncentrat av K-vitaminberoende koagulationsfaktorer (för närvarande Ocplex) så snabbt som möjligt efter det att blödning konstaterats till fall som inte initialt är djupt medvetandesänkta. Behandling med färskfrusen plasma utgör andrahandsalternativ.
 - Till alla patienter ges dessutom K-vitamin (Konakion 10 mg i.v.).
- NOAK-behandling
 - Ge antidot om tillgängligt (Endast Praxbind till Pradaxa tillgängligt för närvarande -finns på IVA).
- Lågmolekylärt heparin
 - Individuell bedömning. Konsult enligt ovan.
 - Vid trombocythämmande behandling finns ingen vedertagen antidot, endast seponering av läkemedel.

b) Blodtrycksbehandling vid blödning

- Akut blodtrycksbehandling till systoliskt blodtryck (SBP) 140 - **180??** mmHg rekommenderas i nuläget. Lämpliga läkemedel; Trandate, Furix, Catapresan (Se Rädda hjärnan – PM).
- Vid behandling enligt Rädda hjärnan-PM skall patienten vara uppkopplad på övervakningsutrustning. Om svårreglerat blodtryck; - täta kontroller tills blodtrycket är stabilt under systoliskt **180??** mmHg.

c) Neurokirurgi?

- **Cerebellär blödning.** Tidig kirurgi kan vara aktuell. Snabb försämring kan ske pga. hjärnstamskompression eller sekundär hydrocefalus; - en frisk storhjärna kan räddas. Neurokirurg (NK)kontakt på vid/bred indikation och eventuellt övertag för bättre operationsberedskap. Blödning >3 cm och progress är oftast operationsindikation. (OBS! motsvarande för infarkt).
- **Storhjärnsblödning.** "Mellanstora" hematom, framförallt inom 1 cm från hjärnytan och påverkan på medvetandegrad, kan vara aktuella för operation. Hematomvolym >100 ml mycket dålig prognos oavsett åtgärd. Generellt för gruppen finns ingen

vinst med neurokirurgisk behandling och neurokirurg behöver endast kontaktas i utvalda fall, t.ex. vid ytligt hematoma enligt ovan eller medvetandepåverkad operabel patient.

1.3 Ischemisk stroke/TIA

1.3.1 Akutbehandling av TIA och hjärninfarkt

- **Rädda hjärnan-patient** – Se särskilt PM i Rädda hjärnan-mappen.
- **Trombocythämmare** - Rutinbehandling i de allra flesta fall!
 - ❓ Oavsett patogenetisk mekanism; Acetylsalicylsyra (ASA) 300 mg ges direkt efter DT hjärna följt av 75 mg dagligen. Ansvarig sjuksköterska kontaktar ansvarig läkare efter DT-svaret. Efter trombolys ges ASA först efter kontroll-DT av hjärnan.
 - ❓ Patienter som redan behandlas med annan trombocythämmare än ASA; oförändrad trombocythämmande behandling under första dygnet.
 - ❓ Vid amaurosis fugax kan behandlingen inledas utan föregående datortomografi (DT).
 - ❓ Om patienten inte kan svälja eller är medvetandesänkt ge supp. Acetylsalicylsyra (ASA) 130 mg x2 i laddningsdos följt av 130 mg dagligen.
 - ❓ Vid intolerans mot ASA ges Clopidogrel laddningsdos 300 mg följt av 75 mg dagligen.

1.3.2 Vid förmaksflimmer eller annan kardiell embolikälla

- Antikoagulantia kan sättas in på TIA-patienter under första dygnet.
- Kontroll-DT efter 1 vecka vid större hjärninfarkt och därefter ställningstagande till insättning av antikoagulantia.
- NOAK (Nya Orale AntiKoagulantia) rekommenderas i första hand.
- Patienter som redan behandlas med antikoagulantia; överväg tillfällig seponering (speciellt vid lillhjärnsinfarkt eller stor hemisfärinfarkt).

1.4 Behandling av expansiv hjärninfarkt

- Vid expansiv mediainfarkt kan hemikranektomi vara aktuell.
OBS! Kontakt med neurokirurg under 1:a dygnet. Oftast något yngre patient, expansiva fynd på DT-hjärna och medvetandepåverkan.
- Vid expansiv lillhjärnsinfarkt kan dekompressionskirurgi övervägas.

1.5 Högt blodtryck

- Akut behandling endast vid blodtryck >230/130 mmHg efter observation under 2 timmar på vårdavdelningen. Helst peroral behandling. Ges i gängse doser.
- Sätt ej ut patientens ordinarie blodtryckssänkande behandling (i synnerhet betablockerare) om inte BT <130/80 under första dygnet.

2. Generellt omhändertagande av samtliga strokepatienter i akutskedet (dvs. de första 3 dygnen)

2.1 Cirkulation i övrigt och elektrolytrubbningar

- **OBS!** Viktigt att optimera systemfaktorer för att minimera risken för att den ischemiska randzonen (penumbran) omvandlas till infarkt och blir permanent. Första dygnen efter stroke kan vara avgörande för utbredningen av penumbrazonen.
- Undvik dehydrering! Snabbt ställningstagande till behovet av i.v. vätska! Ge Ringer-Acetat de två första vård dygnen (undvik glucoslösningar).

2.1.1 Förhöjt blodsocker

- Normoglukemi eftersträvas. Nivåer upp till 15 mmol/l accepteras. Behandling enligt gängse principer.

2.1.2 Feber

- Vid $>37,5^{\circ}\text{C}$; ge Paracetamol 1 gram.
- Vid $>38^{\circ}\text{C}$; Ta CRP, LPK och urinsticka. (Om ej redan taget det senaste dygnet.)

2.1.3 Hypoxi

- Fria luftvägar, eventuellt nästub.
- Ge syrgas vid hypoxi; vid saturation $<94\%$ ges syrgas på gramma eller öppen mask 2-4 lit/min v.b.
- Vid kronisk hypoxi (saturation $<90\%$) och kronisk koldioxidretention (KOL) kontaktas läkare för vidare ordination.

2.2 Trombosprofilax på helt immobiliserade patienter

- Lågmolekylärt heparin i profylaxdos sätts in dag 2 vid hjärninfarkt.
- Vid hjärnblödning kan lågmolekylärt heparin övervägas efter några dygn om tillståndet är stabilt.

2.3 Krampanfall

- Vid upprepade anfall under akutskedet är det indicerat med en kortare tids anfallsbehandling. Levetiracetam kan vara en lämplig behandling för i.v. och peroralt bruk.

2.4 Övervakning

- Strokekontroller enligt övervakningsschema -se Appendix II, är obligatoriskt. Dessa görs första vård dygnet var 4:e timme, om ej annat ordinerar.
- Tätare eller fortsatta strokekontroller enligt läkarordination på patienter med blödning eller infarkt i bakre skallgropen samt malign mediainfarkt. Risk för snabb symtomutveckling och kontroller minst varannan timme, speciellt av medvetandet.
- EKG dag 2 vid hjärninfarkter och TIA.

2.5 Omhändertagande av patient med sväljningssvårigheter

- Strokeobservation inklusive sväljningstest med vatten tsk-vis utförs av van avdelningspersonal för att pröva patientens sväljningsförmåga enligt anvisning på baksidan av strokekontrollistan (se bilaga). Se även PM - "Sväljscreening slutenvård Blekingesjukhuset."
- Om patienten är medvetslös och inte kan medverka till sväljningstestning sätts Ringer-Acetat i.v. omgående, efter ordination av läkare. Vidare sväljningsbedömning av logoped när det är möjligt.
- Vätskebehandling med Ringer-Acetat kan ges de första två dygnen. Om inte behandlingen övergår i en rent palliativ fas påbörjas därefter nutrition via nasogastrisk sond.
- Om inte sväljningssvårigheterna verkar övergående ställningstagande till PEG i samråd med logoped.

3. Fortsatt utredning med fokus på bakomliggande orsak till hjärninfarkt/TIA och hjärnblödning samt sekundärprofylax

3.1 Undersökningar/provtagningar

3.1.1 Carotisundersökning

- Indikation:
 - Alla patienter med TIA eller lindrig hjärninfarkt inom carotisterritoriet som potentiellt kan bli föremål för carotiskirurgi.
- Ultraljud eller DT-angio bör utföras snarast inom 2 dygn (48 timmar).
- Carotisoperation skall ske skyndsamt, dock ej på jourtid och senast inom 2 veckor.

3.1.2 Diagnostik av förmaksflimmer

- **Remiss till thoraxkliniken för 48 tim långtidsEKG-registrering**
 - Diagnos ischemisk stroke eller TIA där orsaken är okänd.
 - Inget tidigare känt förmaksflimmer.
 - Bedöms vara kandidat för antikoagulantibehandling om förmaksflimmer diagnostiseras.
- Under **2020 kommer troligen klin fys ta över långtidsEKG-registreringen**

3.1.3 Ekokardiografi

- Indikation:
 - Hjärninfarkt eller TIA om fynd av kardiell embolikälla i det enskilda fallet påverkar behandlingen (t.ex. antikoagulantibehandling, endokardit-behandling).
 - Rutin hos unga (<60 år) om annan orsak till stroke inte framkommit.
- Indikationen mindre stark vid annan misstänkt huvudmekanism (t.ex. signifikant carotisstenos påvisad vid duplexundersökning).
- Indikationen bortfaller vid kroniskt förmaksflimmer.
- Ej rutin hos patienter äldre än 60 år och utan tecken på hjärtsjukdom.

3.1.4 Magnetresonanstomografi (MRT)

- Kan vara indicerad vid oklar diagnos i synnerhet i bakre skallgropen där DT-diagnostik är svårare.
- Vid differentialdiagnostiska problem, t.ex. misstanke på multipel skleros.
- För diagnostik av sinustrombos, extrakraniell dissektion, intracerebralt hematoma (senare än 2 veckor efter insjuknandet).
- Diffusions-MRT kan vara av värde för differentialdiagnostik och för att påvisa en akut infarkts läge och storlek.

3.2 Utvidgad utredning hos yngre patienter med stroke (18-55 år)

- DT-angiografi från arcus och upp.

- MRT hjärna
- Kontrastförstärkt ekokardiografi
- Esofagusekokardiografi **endast i utvalda fall. Behövs ej vid PFO-utredning**
- Överväg vidare utredning; vanlig orsak är tidig förekomst av kärlriskfaktorer eller kärldissektion.

3.2.1 Ovanliga diagnoser

- Sinustrombos
- Paradoxal embolism
- Fabrys sjukdom
- Antikardiolipinsyndrom
- Vaskulit

3.3 Cerebral blödning

- Överväg bakomliggande orsak;
 - Hypertoniblödning
 - Amyloidangiopati
 - Blödning i tumör
 - Kärlmissbildning

3.4 Differentialdiagnoser

Vanlig felkälla är tidigare stroke eller annan hjärnsjukdom med försämring av symptom vid t.ex. infektion eller annan allmänpåverkan t.ex. dehydrering.

3.4.1 Neurologiska sjukdomar

- Epilepsi;
 - Partiell epilepsi som i sin tur kan bero på t.ex. hjärntumör eller kärlmissbildning.
 - Postapoplektisk epilepsi bör alltid övervägas om patienten drabbas av nya neurologiska symptom motsvarande det tidigare drabbade området.
- Intrakraniell expansivitet
- Herpesencephalit
- Skov av demyeliniserande sjukdom
- Migrän (inklusive retinal migrän)

3.4.2 Icke neurologiska sjukdomar

- Metabol störning och allmänna infektionssjukdomar med feber; hypo- eller hyperglykemi, elektrolytrubbningar, intoxicationer, UVI, virus med mera.
- Temporalisarterit
- Ögonsjukdomar
- Öronsjukdomar
- Funktionella symptom

3.5 Sekundärprofylax

- ASA-behandling från akutskedet fortsätter vanligtvis som sekundärprofylax. Vid ASA-allergi används istället Clopidogrel. Vid fynd av förmaksflimmer eller annan potent kardiell embolikälla; NOAK behandling.
- Blodtrycket behandlas efter akutskedet enligt gängse riktlinjer dvs. målblodtryck mindre än 140/90 mmHg.
- Statinbehandling rutinmässigt till alla där dosen anpassas efter LDL-nivån med målsättning att LDL ska vara under 1.8 µkat/L. Patienter med dålig prognos får bedömas individuellt.
- Carotiskirurgi vid symtomgivande tät stenosis och operabel patient. Operation kan normalt övervägas vid stenosgrad >70 % enligt lokal stenosgradering. Inför eventuell operation skall neurologkonsult i Karlskrona alternativt ansvarig överläkare på avd. 58 kontaktas. Denne bedömer patienten och sköter vid behov vidare kontakt med kärlkirurg.
- Individuell noggrann genomgång av övriga riskfaktorer, t.ex. fysisk inaktivitet, BMI >25 och rökning. OBS! Tänk på att kontakta sjukgymnast vid låg fysisk aktivitet.

3.6 Behandling vid vissa specifika tillstånd

3.6.1 Kärldissektion

Standard är ASA-behandling alternativt Clopidogrel. Vid speciellt hotfulla situationer kan antikoagulantibehandling och kärlintervention övervägas.

3.6.2 Sinustrombos

Standard är lågmolekylärt heparin/antikoagulantia även om det finns en sekundär parenkymbldning. Utredning krävs av bakomliggande orsak. Vid svåra fall kan lokal trombolys vara aktuell.

3.6.3 Vid hjärnfarkt och tidigare genomgången hjärnblödning

Vid exempelvis tidigare genomgången hypertoni-blödning med aktuellt välkontrollerat blodtryck kan ASA eller AK övervägas efter individuellt ställningstagande.

Slutning av vänster förmaksöra (sk förmaksplugg) är möjlig, men betraktas av Socialstyrelsen som åtgärd inom FoU enligt riktlinjer för stroke 2017.

3.6.4 Vid hjärnfarkt/TIA orsakad av storkärlssjukdom med hög risk för återinsjuknande

Dubbel trombocythämning kan övervägas under maximalt 1 månad. **Framförallt dokumenterat vid lindrig hjärnfarkt.**

4. Uppföljning/Utskrivning

Vid utskrivning från strokeenheten får patienten ett utskrivningsmeddelande och läkemedelslista. Vid hjärninfarkt/hjärnblödning gäller förbud att framföra motorfordon i minimum 3 månader, gällande yrkeschaufförer i minimum 6 månader. Efter TIA gäller alltid 1 månads förbud att framföra motorfordon.

Ställningstagande till vapenlicens vid vapeninnehav.

Uppföljning av stroke och TIA sker i primärvården vilka skall tillsändas remiss. Av remissen skall framgå individanpassade konkreta mål med uppföljningen. I enstaka fall kan uppföljning på neurologmottagningen vara motiverat, exempelvis vid ovanliga strokemekanismer, yngre patienter eller icke färdig medicinsk utredning.

Råd till primärvården + länk till SKL;

<http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/beslutsstod-korkort-efter-stroke-tia.html>

Gällande korrekt diagnossättning; – Se Appendix I "Utdrag från Riksstroke's diagnoslathund"

För komplett lathund var god se;

<http://www.riksstroke.org/wp-content/uploads/2018/01/Riksstroke-diagnos-lathund-reviderad-nov-2017.pdf>

När patienter har vårdats på annan enhet än strokeenhet är det viktigt att respektive strokeenhet meddelas för möjlighet till registrering i det nationella kvalitetsregistret Riksstroke.

B. Rehabiliterande del

Rehabilitering efter stroke är nödvändig för att återfå eller förbättra kroppsfunktioner. I Sverige får de flesta sin rehabilitering utanför akutsjukhuset. I landstinget Blekinge erbjuds teambaserad rehabilitering i både sluten vård och öppen vård beroende på patientens funktionsnedsättningar. Ett multiprofessionellt team träffar patienter på strokeenheten i samband med inskrivning eller då medicinska tillståndet tillåter det, bedömer patientens funktionsnedsättningar och erbjuder tidiga rehabiliteringsinsatser.

Teambaserad intensiv strokerehabilitering i sluten vård är en patientcentrerad process med flera professioner involverade för att stötta den enskilda individen. I teamet ingår läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, kurator, sjuksköterska och undersköterska. Innehållet i rehabiliteringen ska vara individanpassat och målinriktat utifrån patientens önskemål och behov. Denna vårdform tillämpas främst på patienter med svår stroke och stort rehabiliteringsbehov som inte bedöms kunna genomföras i andra former för rehabilitering och har visat ha en bättre effekt på funktions- och aktivitetsförmåga, jämfört med andra former av rehabilitering. En förutsättning är att rehabiliteringspotential finns, vilket innebär att patienten kan medverka vid träning samt orka genomföra slutenvårdens intensiva träning.

Vid lindrig till måttlig stroke utan betydande kognitiva nedsättningar kan en alternativ rehabilitering i tidig fas erbjudas som innebär tidigare hemgång från sjukhus med fortsatt rehabilitering i hemmet. Denna rehabilitering ges eller koordineras då av ett specialutbildat interdisciplinärt rehabiliteringsteam. Även här är rehabilitering individanpassat och målinriktad. Åtgärden minskar risken för död och ADL-beroende och medför en kortare initial vårdtid samt innebär en låg till måttlig kostnad per effekt, jämfört med sedvanlig vård på strokeenhet.

Individanpassad och målinriktad rehabilitering kan erbjudas även i öppenvårdsregi för personer med lindrig stroke eller personer som har genomfört rehabilitering i sluten vård eller i hemmet. I dessa fall anses den fortsatta rehabiliteringen leda till ökad självständighet och delaktighet i vardagliga livet, understödja arbetsåtergång, minska behov av kommunala resurser och förbättra personens livskvalitet.

Förbättringar av patientens fysiska och kognitiva funktioner försätter även flera år efter att en stroke har inträffat, beroende på individens förutsättningar, det vill säga avvikelsegrad i kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt faciliterande och hindrande faktorer hos individen och omgivningen. Bedömning av behov av rehabiliteringsinsatser i sluten – eller öppenvård kan därför vara aktuell även i senare skede, om ovan nämnda förutsättningar förändras, även om patienten initialt inte har kunnat fullfölja ett rehabiliteringsprogram.

1. Inneliggande Rehabilitering

Rehabiliteringsenheten, som del i strokeenheten, är en specialistvårdsenhet, som i första hand främjar särskilda rehabiliterande insatser snarare än internmedicinska och kirurgiska insatser. Rehabilitering definieras som insatser som bidrar till att en person med förvärvat funktionsnedsättning, med hänsyn till helhetsperspektiv utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktions- och aktivitetsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhället. Ett rehabiliteringsprogram för inneliggande rehabilitering omfattar minst tre (3) timmars rehabiliteringsinsatser per patient dagligen med hjälp av ett koordinerat interdisciplinärt team. Dessa insatser kan omfatta sjukgymnastik, arbetsterapi, talterapi, kognitiv terapi, neuropsykologiska insatser, mobilisering m.fl.

Akut inneliggande rehabilitering rekommenderas när patientens hälsotillstånd är sådant att andra enheter rimligen inte kan erbjuda de intensiva rehabiliteringsinsatser som krävs. I landstinget Blekinge finns två (2) strokeenheter, en i Karlshamn och en i Karlskrona, där tidig rehabilitering ges och där teamen på respektive enhet samarbetar kring både det akuta skedet och rehabiliteringen.

1.1 Förutsättningar för inneliggande rehabilitering

Inneliggande rehabilitering är medicinskt nödvändig när samtliga följande förutsättningar föreligger:

1. Individen har drabbats av en stroke som har resulterat i en betydande försämring av funktionsförmågan så att det inte är tillräckligt för att återhämta sig i en mindre intensiv miljö;
2. Individens övergripande hälsotillstånd och medicinska behov talar för en risk för medicinsk instabilitet eller ett behov av läkare och annan sjukvårdspersonal som inte är tillgänglig utanför slutenvårdsmiljön;
3. Individen behöver ett intensivt interdisciplinärt, samordnat rehabiliteringsprogram med minst tre (3) timmars aktivt deltagande dagligen;
4. Individen är medicinskt stabil så att det inte längre krävs medicinska/kirurgiska slutenvårdsinsatser;
5. Individen är i stånd till att aktivt delta i ett rehabiliteringsprogram, vilket kräver respons till verbala, visuella och/eller taktila stimuli samt förmåga att följa enkla kommandon. För ytterligare information om kognitiv status, hänvisas till Rancho Los Amigos Cognitive Scale;
6. Individens mentala och fysiska tillstånd innan insjuknande/skada indikerar att det finns en betydande potential för förbättringar;
7. Individen förväntas visa mätbara funktionella förbättringar inom högst sju (7) till fjorton (14) dagar (beroende på underliggande diagnos/sjukdom) från inskrivningen på rehabiliteringsavdelningen;
8. Rehabiliteringen omfattar en utskrivningsplan.

1.2. Kontraindicerade faktorer för inneliggande rehabilitering

En annan form av rehabilitering utanför sjukhuset eller inneliggande vård bör erbjudas när en eller flera av följande faktorer föreligger:

1. **Oförmåga att delta:** Patienten kan inte tolerera 3 timmars behandling per dag.
2. **Ovilja att delta:** Patienten vill inte delta i fysioterapi/arbetsterapi/talterapi och/eller visar inga tecken på eller bristande motivation i tidigare försök att utföra terapi
3. **Nedsatt rehabiliteringspotential:** Patientens aktuella funktionella status bedöms vara väldigt nedsatt och förväntas inte förbättras av inneliggande rehabiliteringsinsatser eller denne är för närvarande inte annorlunda än sin habituella baslinje (bekräftat av tidigare historia, journaler, eller tillförlitlig källa).
4. **Demens:** Patienten har en kronisk kognitiv svikt som inte förväntas förbättras och gör rehabiliteringsförsök osannolikt eller omöjligt.
5. **Behöver inte hjälp från åtminstone 2 olika paramedicinare:** Patienten måste visa nyttan av att arbeta med åtminstone två av dessa: fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped.
6. **Akut sjukdom eller tillstånd:** Patienten har en akut sjukdom/tillstånd som kräver medicinsk intervention före överföring till en rehabiliteringsavdelning - dessa inkluderar:
 - a. sepsis (infektion med feber och förhöjda infektionsparametrar)
 - b. delirium (medicinuutlöst, uttorkning, infektionssjukdomar, förgiftning)
 - c. instabila vitala parametrar (allvarlig hyper- eller hypotension, allvarliga arytmier, hypoxi trots syretillskott)
 - d. akut psykotisk episod (inklusive aktiva hallucinationer eller vanföreställningar)
 - e. okontrollerad smärta (patientens smärta kontrolleras inte tillräckligt för att möjliggöra deltagande i terapi)
 - f. svår anemi
 - g. extrem trötthet eller slöhet på grund av sjukdom
7. **Pågående utredning eller kommande operativa åtgärder:** Patienten är under utredning för DVT, hjärtrubbning, stroke, infektion, anemi, bröstsmärta, blödning, etc. eller är på väg att genomgå en intervention (operation, radiologisk undersökning, labbtest) som kan påverka differentialdiagnos eller det omedelbara förloppet av patientens medicinska/kirurgiska status.

2. Arbetsterapeut

2.1 Bedömning

Arbetsterapeuten på strokeenheten träffar patienten snarast efter det att denne blivit inlagd på strokeenheten. Så snart patientens allmäntillstånd tillåter (ofta redan första vardagen efter inläggning) påbörjas ADL – bedömning (Karlshamn) respektive bedside-bedömning (Karlskrona) tillsammans med sjukgymnast. Fortsatta bedömningar görs därefter vid behov;

- Anamnes och bedömning av nuvarande aktivitetsförmåga och aktivitetsutförande gällande ADL-aktiviteter inom personlig vård, boende, utbildning/arbete och fritid. Bedömning av aktivitetsförmågan sker med stöd av strukturerade observationer, standardiserade tester samt skapande aktiviteter. Aktivitetsutförandet analyseras utifrån motoriska och kognitiva aspekter.
- Handstatus med standardiserade tester samt i praktisk aktivitet. Bedömning görs av rörelseförmåga, handstyrka (Jamar/Grippit), känsel (monofilament), finmotorik (pinnprov/Purdue Pegboard) samt greppförmåga.
- Bedömning av kognitiv förmåga görs via strukturerade observationer i aktivitet och/eller via kognitiva papper/penna uppgifter t.ex. Cognistat, AMPS, DBF, RBMT, klocktestet, Alberts test, pokalen.
- Bedömning av hemmiljön görs vid hembesök eller intervju för ställningstagande till behov av hjälpmedel/bostadsanpassning inför permission/utskrivning. Hembesöket görs tillsammans med patienten och eventuell anhörig, sjukgymnast från avdelningen samt arbetsterapeut i hemsjukvården. Hembesöket syftar även till att bedöma patientens aktivitetsförmåga i sin hemmiljö och för att kartlägga vad hon/han behöver träna på återstående tid av rehabiliteringsvistelsen.

2.2 Insatser

Träning på arbetsterapin och/eller på avdelningen sker alla vardagar för varje patient där behov finns och anpassas efter patientens aktivitetsnivå och behov av träning.

- **Träning i aktivitet** syftar till att förbättra dels den motoriska och dels den kognitiva förmågan. Det kan t.ex. vara aktiviteter inom personlig vård som tränas på vårdavdelningen. Det kan även vara aktiviteter för att underlätta det egna boendet eller aktiviteter inriktad mot fritid.
- **Funktionsträning** utförs gällande motorik och kognition för att förbättra ADL-förmågan. Exempel på funktionsträning som kan genomföras är individuell hand-/arm träning, ståträning, träning av koncentration, uppmärksamhet eller problemlösning genom olika papper/penna uppgifter eller genom hantverksaktiviteter.
- **Kompensatorisk träning** handlar om att träna inre och yttre strategier i form av förändrat utförande eller utprovning/träning av tekniska hjälpmedel.

- **Hjälpmedelsförskrivning** Arbetsterapeuten utprovar och förskriver individuella hjälpmedel som patienten behöver på avdelningen eller i samband med permission/utskrivning. Förskrivning av hjälpmedel till hemmet görs även av och i samråd med arbetsterapeuten i hemsjukvården.

I den gemensamma rehabiliteringsplanen förnyas aktivitets- och funktionsdelmål efterhand vid möten med patient, övriga paramedicinare samt vid ronder. Tidig kontakt tas med ansvarig arbetsterapeut i hemsjukvård/kommun för att förbereda inför hembesök och permissioner.

Arbetsterapeuten tillsammans med övriga i teamet strävar mot en god samverkan med anhöriga, vilket sker kontinuerligt under vårdtiden. Anhöriga erbjuds delta vid behandling/träning, i samband med teamsamtal informeras anhöriga om träningen och det görs även en planering framåt som de är delaktiga i.

Vid utskrivning överrapporteras patient vid behov till arbetsterapeut i kommunen, primärvården eller till specialistrehabiliteringen.

Sista fasen av rehabiliteringen kan ske i patientens hemmiljö. Rehabiliteringsansvaret tas då över av SPRIH-teamet (Specialiserad rehabilitering i hemmet). SPRIH-teamet består av sjukgymnast, arbetsterapeut och rehabundersköterska. Till teamet finns även knutet läkare, logoped, kurator och sjuksköterska.

3. Sjukgymnast

3.1 Bedömning

Sjukgymnasten/fysioterapeuten på strokeenheten träffar patienten snarast efter det att denne blivit inlagd på strokeenheten eller så snart patientens tillstånd tillåter, ofta redan första vardagen efter inläggning. (I Karlskrona görs bedside- bedömning tillsammans med arbetsterapeut. I Karlshamn görs en neurologisk bedömning av sjukgymnast).

Den sjukgymnastiska bedömningen utförs enligt följande:

Anamnes: för att fastställa patientens tidigare funktionsstatus och nytillkomna problem/svårigheter inom rörelseförmåga, förflyttning, gångförmåga, balans, ADL och eventuella hjälpmedel.

Status: för att fastställa patientens aktuella funktionsstatus samt identifiera problem/svårigheter inom följande områden:

- Förflyttning: förflyttning i säng, från säng till stol. Förmåga att gå inne, ute och i trappa. Hur mycket medverkar patienten? Finns behov av hjälpmedel?
- Selektiv motorik: övre extremitet och nedre extremitet. Grov kraft och funktionell rörlighet (Motor Assesment Scale M-MAS UAS -99).
- Balans: i sittande och stående, statisk och dynamisk. Föreligger fallrisk? Bergs Balansskala, Timed Up and Go – TUG, 10 meter gångtest, 6 minuter gångtest.
- Sensibilitet: yttlig och djup känsel, taktil gnosis.
- Andning/cirkulation: föreligger slemretention? Finns risk för komplikationer?
- Koordination: diadokokinesi, reciproka rörelser, finger-näs, häl-knä.
- Smärta; VAS
- Kognition: orientering x 3, hur tar patienten instruktioner? Har patienten insikt om sina problem?
- Muskeltonus: graderas enligt Ashworth-skalan. Risk för kontrakturer?
- Perception, synfält
- Kommunikation
- Motivation

3.2 Insatser

Bedömning och träning sker dagligen på vardagar.

Träningen är schemalagd och sker antingen på avdelningen eller på sjukgymnastiken.

Gymnastiksal och träningsbassäng finns också tillgänglig och ibland sker träning utomhus.

Den initiala träningen går ut på att klara av korta förflyttningar, hitta balansen i sittande samt bedömning av komplikationsrisker. Därefter övergår man till att träna längre förflyttningar och gång. Träning av patientens förflyttnings- och gångförmåga sker delvis tillsammans med omvårdnadspersonalen. Vid behov hålls en speciell förflyttnings-genomgång med berörd personal. Patientens förflyttningsförmåga rapporteras kontinuerligt.

Hjälpmedel för att underlätta vid förflyttning och gång finns på avdelningen. Sjukgymnasten ombesörjer förskrivning av bland annat gånghjälpmedel.

Stor vikt läggs vid balans- styrke-, koordinations- konditions- och andningsträning samt kontrakturprofylax. Stimulering till aktivitet på den svaga sidan tillämpas kontinuerligt. Den sjukgymnastiska träningen inriktar sig på att förbättra motoriska färdigheter och bibehålla det som finns.

Parallellt observeras och tränas kontinuerligt patientens kognitiva funktioner som förmågan att ta initiativ och förstå instruktioner samt träning av koncentration och minne.

Sjukgymnasten/fysioterapeuten medverkar i:

- Teamsamtal: informationsmöte för patient och närstående med arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare, logoped, kurator och sjuksköterska. Se Dokument; "Teamsamtal".
- Hembesök: allt eftersom rehabiliteringen fortskrider kommer patienten att tillbringa mer tid i hemmet. Som en förberedelse för detta gör arbetsterapeut och sjukgymnast hembesök tillsammans med patienten för att bedöma patientens aktivitetsförmåga i sin hemmiljö och för att kartlägga vad hon/han behöver träna på återstående tid av rehabiliteringsvistelsen. Hembesöket syftar även till att undersöka eventuellt behov av bostadsanpassning och/eller hjälpinsatser i hemmet. Se Dokument "Hembesök".

Sjukgymnasten/fysioterapeuten medverkar även när det gäller:

- Sekundärprofylax gällande fall och frakturer, skuldersmärta, spasticitet, kontrakturer och pneumoni.
- Planering inför hemgång
- SPRIH

Sista fasen av den ineliggande rehabiliteringen kan i vissa fall ske i patientens hemmiljö. Rehabiliteringsansvaret tas då över av SPRIH-teamet (Specialiserad rehabilitering i hemmet). SPRIH-teamet består av sjukgymnast, arbetsterapeut och rehabundersköterska. Till teamet finns även knutet läkare, logoped, kurator och sjuksköterska.

Vid utskrivning överrapporteras patienten vid behov till sjukgymnast/fysioterapeut i kommunen, primärvården eller för specialistrehabilitering.

4. Logoped

4.1 Bedömning

Logopedisk bedömning sker vid behov på initiativ av övriga medlemmar i stroke teamet/sjuksköterska eller läkare på avdelningen. Vid hjärnskada kan såväl språk, tal och sväljning påverkas på olika sätt. Diagnoserna afasi, dysartri respektive dysfagi sätts vid svårigheter. Ibland föreligger nedsättning av flera förmågor samtidigt. Korrekt differentialdiagnostik mellan afasi och dysartri är viktig.

Bedömning görs av:

- Språk/afasi (hörförståelse, läsförmåga, muntlig uttrycksförmåga och skrivförmåga) med t ex Grundläggande Neuropsykologisk Undersökning (GNU) afasidelen, Neurolingvistisk Afasiundersökning (A-ning) eller föremål/bilder/text.
- Tal/dysartri (talandning, röstbildning, oralmotorik, nasalitet, artikulation, prosodi och förståelighet) med t ex Dysartritest H&S.
- Sväljning/dysfagi (inspektion oralt, munmotorisk screening och sväljobservation av valda konsistenser). Klinisk sväljbedömning görs vid behov efter en första måltidsobservation eller screening utförd av vårdpersonal. Vid ätobservation under patientens första måltid provas lämplig konsistens ut. Vid svårigheter skall logoped kontaktas. Resultatet av ätobservationen skall dokumenteras i både omvårdnadsstatus samt i en omvårdnadsanteckning under sökordet nutrition. I samråd med vårdpersonal och läkare avgörs om nutriering per os är lämplig/möjlig. Vid stora, komplicerade eller kvarstående svårigheter kan instrumentell bedömning göras. Remiss skickas då av logoped eller läkare i samråd till Röntgen för Terapeutisk sväljningsröntgen med logoped respektive ÖNH-läkare för Fiberendoskopisk undersökning av sväljningen (FUS).

4.2 Behandling

Logopedisk behandling sker på olika plan för att:

- Förbättra funktionerna (t.ex. läs- och skrivträning, mun- och talträning, sväljträning)
- Lära in kompensation för att klara olika aktiviteter som rör språk, tal och sväljning (t.ex. samtala med konkret stöd, öva in strategier vid ordsökning, läsning och skrivning, anpassa taltempo, använda hjälpmedel, träna in sväljtekniker, konsistensanpassa).
- Underlätta social delaktighet (t.ex. uppmuntra och stötta patienten, ge närstående och personal information och råd hur underlätta kommunikation, optimera intag av mat och dryck tillsammans med andra).

5. Dietist

5.1 Bedömning

Bedömning av nutritionsstatus görs tidigt i sjukdomsförloppet och upprepas med jämna tidsintervall med samtidig regelbunden viktuppföljning 1-2 gånger/vecka. Dietist ska kontaktas för konsultation vid behov. Behandlingen måste utformas individuellt och följas upp och utvärderas regelbundet. Val av lämplig form av nutritionsterapi avgörs av tugg- och sväljförmåga samt bedömt behov av i första hand energi och protein.

5.2 Insatser

Oral nutritionsterapi bygger på kost i hel eller anpassad konsistens, eventuellt kompletterad med oralt nutritionsstöd i form av kosttillskott. Vitamin- och mineral supplementering bör ske vid behov. För val och dosering av näringsdryck bör samråd ske med dietist. Personer med nedsatt aptit bör erbjudas energi- och proteinrik kost. När det inte är möjligt att täcka beräknat behov av energi- och näringsämnen med oral nutritionsterapi, måste artificiell nutrition övervägas, antingen som enda näringskälla eller i kombination med oral nutritionsterapi.

Artificiell nutrition kan delas in i enteral (via tarmen) eller parenteral (vid sidan av tarmen). Enteral nutrition är att föredra så länge absorptionen i tarmen fungerar. Vid övergående dysfagi rekommenderas nasogastrisk sond men vid långvariga eller bestående svårigheter rekommenderas PEG. För val och dosering av sondnäring bör samråd ske med dietist som kan göra en individuell bedömning av typ och mängd utifrån patientens behov. Viktigt att utvärdering/uppföljning av artificiell nutrition finns i planeringen samt vem som är ansvarig för uppföljningen.

6. Kurator

6.1 Socialt arbete och psykosocialt behandlingsarbete

Kurators arbete inriktar sig på sociala och psykosociala problem.

Utifrån patientens och/eller närstående behov träffas en överenskommelse om fortsatt kuratorskontakt.

Kontakten med kurator kan innefattas av:

- Samtalsbehandling- att ge psykologiskt stöd till patient och/eller närstående- exempelvis krissamtal, stödsamtal, bearbetande samtal och motivationssamtal. Vid fördjupat behov av samtalsstöd till närstående rekommenderas kontakt med primärvården.
- Social information och rådgivning. Information om samhällets resurser vid sjukdom avseende exempelvis omvårdnad, ekonomi, utformande av fullmakt, godmanskap, boende, arbete och rehabilitering.
- Hjälp i kontakten med myndigheter eller andra vårdgivare för initiering av insatser, hjälp med ansökningar och stöd vid kontakt med exempelvis arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och LSS-handläggare.

6.2. Utredning och bedömning av vårdbehov utifrån ett psykosocialt perspektiv

Kuratorn medverkar vid teamronder och pulsronder. En första bedömning görs då om kuratorskontakt bör initieras. I vissa fall kan inte dessa mötestillfällen inväntas, exempelvis vid misstanke om krisreaktioner, oro/ångest, nedstämdhet/depression. Kuratorn kontaktas då direkt av annan vårdpersonal. Även närstående erbjuds kontakt vid behov.

Vid en mer omfattande kontakt tas anamnes med inriktning på det psykosociala området; familjesituation, bostad, ekonomi, arbete, skola/utbildning, fritid, socialt nätverk/stöd-belastning, psykosocial bakgrund, funktionsförmåga, behandlingskontakter, myndighetskontakter, aktuell psykisk och social problematik. Utifrån anamnes görs sedan en bedömning av behov av kuratorsåtgärder.

7. Sexolog

Arbetet med sexuell hälsa sker på olika nivåer utifrån PLISSIT-modellen (Permission, Limited Information, Specific Suggestions, Intensive Therapy). Det innebär att all personal utifrån egna förutsättningar skall kunna möta sexuella frågeställningar. Vid behov av ytterligare insatser kan patienter hänvisas till sexologerna på kliniken som är placerade i Karlshamn. Patienterna kan ta kontakt via egenremiss eller via internremiss under vårdtillfället.

Behandlingen kan vara terapeutiskt inriktade samtal, råd och stöd. Insatser, som till exempel farmakologisk behandling, sker i samverkan med läkaren och vid behov med andra teammedlemmar. Informationsbroschyr om sexuell hälsa finns i väntrum och patientpärm.

Appendix I

Utdrag ur Riksstrokes diagnoslathund

För komplett lathund var god se;

<http://www.riksstroke.org/wp-content/uploads/2018/01/Riksstroke-diagnos-lathund-reviderad-nov-2017.pdf>

1. AKUT STROKE

Subarachnoidalblödning **I60**

Intracerebralblödning **I61**

Observera: Intracerebral blödning ska vara verifierad med bilddiagnostik eller obduktion. Endast patienter med nytillkommen blödning i relation till det aktuella vårdtillfället får denna diagnoskod. För tidigare stroke – se nedan, under punkt 4. Vid traumatiska blödningar – se nedan, under punkt 8.

Cerebral infarkt **I63**

Storkärlssjukdom I63.0

Småkärlssjukdom (lakunär) I63.3

Kardioembolisk stroke I63.4

Ospecificerad(okänd orsak) I63.9

Stroke ej specificerad som blödning eller infarkt **I64.9**

Observera: Används om klinisk strokebild föreligger men bilddiagnostik eller obduktion ej har gjorts.

TIA **G45**

Vertebralis G45.0

Carotis G45.1

Amaurosis fugax G45.3

UNS G45.9

Observera: Diagnosen TIA används vid fokala symtom som kvarstår mindre än 24 timmar och som är nytillkomna. Om strokesymtomen försvinner fullständigt efter trombolys och ingen strokemimic misstänks ges också diagnosen TIA och används även om bilddiagnostik påvisat färsk lesion

4. TIDIGARE STROKE ELLER TIA

Tidigare subarachnoidalblödning **med** sequelae I69.0

Tidigare intracerebral blödning **med** sequelae I69.1

Tidigare cerebral infarkt **med** sequelae I69.3

Tidigare stroke **med** sequelae I69.4

Tidigare stroke **utan** sequelae Z86.7C

Tidigare TIA Z86.6A

Observera: Riksstroke rekommenderar att I69/Z86 vid behov används som bidiagnos när patienter som tidigare haft en stroke respektive TIA rehospitaliseras utan att ha en ny stroke-/TIA-händelse, oavsett om inläggningen sker inom 12 månader från det ursprungliga insjuknandet eller ej. Patienter med diagnos I69/Z86 registreras inte i Riksstroke.

8. TRAUMATISKA HJÄRNBLODNINGAR

Traumatisk hjärnblödning S06.3

Traumatisk epidural blödning S06.4

Traumatisk subduralblödning S06.5

Traumatisk subarachnoidalblödning S06.6

Observera: Vid S06 används även orsakskod (skadans yttre orsak). Traumatiska hjärnblödningar ingår inte i definitionen av stroke och registreras inte i Riksstroke.



Namn och födelsedata		Kontroll 1	Kontroll 2	Kontroll 3	Kontroll 4	Kontroll 5	Kontroll 6
Medvetandegrad enl. ACVPU-skalan <i>V.g. se baksidan.</i>							
Blodtryck							
Puls							
Saturation <i>(Om <94% ge syrgas 2-4 lit./minut enl. vårdprogram stroke.)</i>							
Temperatur OBS! Rektaltemp! <i>(Vid >37,5°C ge Paracetamol 1 gram. Vid >38°C ta även CRP, LPK samt urinsticka enl. vårdprogram stroke.)</i>							
Blodsocker <i>(Fortsatta kontroller endast om >6,5 mmol/l.)</i>							
Bladderscan <i>(Fortsatta kontroller om res.urin >200 ml.)</i> <i>(Ev. RIK/KAD om res.urin >400 ml (på läkarordination enl. PM))</i>							
Tal							
0= Utan anmärkning							
1= Sluddrigt tal							
2= Avvikande tal (t.ex. svårt att hitta ord)							
3= Talar ej							
Förståelse (lyder uppmaning) Ja/Nej <i>(Be t.ex. pat. öppna/sluta ögonen.)</i>							
Pares arm Börja med den icke paretiska armen. Be pat. lyfta (ev. hjälp upp) armen i 45° vinkel mot sängen med handflatan nedåt. <u>Kryssa för svagaste sidan:</u> Vå ☐ Hö ☐							
0= Håller kvar svagaste armen i minst 10 sek.							
1= Armen sjunker inom 10 sek men når inte sängen.							
2= Armen sjunker till sängen inom 10 sek men pat. försöker hålla emot tyngdkraften.							
3= Armen faller omedelbart, inget motstånd mot tyngdkraften. Pat rör armen mot underlaget.							
4= Ingen rörlighet i armen.							
Pares fingrar Be pat. sträcka ut sina fingrar så mycket som möjligt. <u>Kryssa för svagaste sidan:</u> Vå ☐ Hö ☐							
0= Normalt (ingen flexion/böjning inom 5 sek.)							
1= Flexion/böjning inom 5 sek men kvarvarande sträckförmåga.							
2= Ingen viljemässig extension/sträckning kvar i 5 sek.							
Pares ben Börja med det icke paretiska benet. Be pat. lyfta (ev. hjälp upp) ett ben i taget i 30° vinkel mot sängen. <u>Kryssa för svagaste sidan:</u> Vå ☐ Hö ☐							
0= Håller kvar svagaste benet i minst 5 sek.							
1= Benet sjunker inom 5 sek men når inte sängen.							
2= Benet faller till sängen inom 5 sek men pat. försöker hålla emot tyngdkraften.							
3= Benet faller omedelbart, inget motstånd mot tyngdkraften. Pat rör benet mot underlaget.							
4= Ingen rörlighet i benet.							
Facialis pares: Ja/Nej Be pat. le och visa tänderna <u>Kryssa för sidan m. pares:</u> Vå ☐ Hö ☐							
Neglect/Synfältsbortfall: Ja/Nej Be pat. ange om dina fingrar syns eller inte i respektive yttre synfält. <u>Vid neglect/bortfall: kryssa för vilken sida:</u> Vå ☐ Hö ☐							
Sväljningssvårigheter: Ja/Nej Prova med 1 tsk vatten till vaken pat. <i>V.g. se flödesschema på baksidan.</i>							
Signatur							

Datum: _____

Rev. 191111/acnc

Övrig information:

OBS! Utförda strokekontroller, inklusive ev. övrig information, ska dokumenteras i patientens journal, dels som

Medvetandegrad enl. **ACVPU**-skalan

A (Alert)	Fullt vaken och alert. (RLS 1)
C (Confusion)	Nytilkommen eller förvärrad förvirring. (=RLS ??)
V (Voice)	Slö men kontaktbar och följer uppmaningar vid tilltal och lätt stimulering. (RLS 2)
P (Pain)	Mycket slö. Kräver smärtsamma stimuli för att bli kontaktbar och kunna följa uppmaningar. (RLS 3)
U (Unresponsive)	Coma. Okontaktbar. Reagerar ej vid tilltal eller smärtstimulering. Stereotypa böj-eller sträckrörelser eller ingen reaktion alls (RLS 4-8)

Sväljningstest till vaken patient

